นวดไทย

Thai Massage *Clínica*

APOSTILA DE MANOBRAS

Vanessa Yumi Kataoka

INSTITUTO YUMI KATAOKA

BOAS-VINDAS

Antes de tocar, presença.

Esta apostila acompanha a sua formação em Thai Massage Clínica. Ela foi pensada para ser o seu material de consulta antes, durante e depois da prática.

A Thai Massage (Nuad Thai) é uma arte terapêutica que une pressão rítmica, alongamentos assistidos, mobilizações articulares e uma atitude de cuidado consciente. No contexto clínico, ela ganha um olhar ainda mais atento: avaliação, objetivo terapêutico, segurança e adaptação da técnica ao corpo real que está à sua frente.

Aqui você vai encontrar a história da tradição, os fundamentos teóricos, os princípios de aplicação, os cuidados de segurança e, no coração deste material, o **catálogo das manobras**, cada uma com imagem, objetivo e passo a passo.

Como usar esta apostila

Estude a teoria primeiro

Os módulos 1 a 4 dão o contexto. Entender o porquê de cada gesto muda a qualidade do seu toque.

Anote sem medo

Os espaços de anotação são seus. Registre sensações, ajustes de postura e o que funcionou com cada cliente.

Pratique com a ficha ao lado

Cada manobra tem uma ficha com posição, objetivo e sequência. Use o tempo indicado na ficha para rever o trecho exato da aula.

Respeite os limites

Releia o módulo de segurança sempre que receber um cliente com condição de saúde específica.

"A técnica abre a porta.
A presença é o que cura."

VANESSA YUMI KATAOKA

SOBRE A AUTORA

Vanessa Yumi Kataoka é massoterapeuta, formadora e mentora com mais de 17 anos de atuação, especialista em Thai Massage Clínica e Consciência Corporal. Fundadora do Instituto Yumi Kataoka.

SUMÁRIO

Sua jornada de estudo

01 **História da Thai Massage** 04
Ayurveda e os rishis, Jivaka, a chegada do budismo, Wat Pho, o reconhecimento oficial e as escolas

02 **Fundamentos teóricos** 13
Lom pran, as dez linhas Sen, pontos de Wat Pho, os elementos e as atitudes do coração

03 **Princípios de aplicação** 21
Postura do terapeuta, ferramentas do corpo, ritmo e respiração

04 **Segurança e olhar clínico** 23
Anamnese, contraindicações, cuidados e preparação do atendimento

05 **Catálogo de manobras** 25
Princípios, abertura e 42 fichas: dorsal, ventral, lateral, sentado e complementos do livro

06 **Anexos** 52
Ficha de anamnese, glossário, referências e anotações

01

MÓDULO

História da Thai Massage

Uma tradição viva, transmitida de mestre para aprendiz por mais de dois milênios, nos templos, nas famílias e nas aldeias do antigo Sião.

Nuad Thai: o nome e o sentido

Em tailandês, **นวด (nuad)** significa massagear, tocar com intenção de curar. A forma tradicional é chamada de **Nuad Boran** (นวดแผนโบราณ), "massagem antiga", ou simplesmente **Nuad Thai**. No Ocidente, ficou conhecida como Thai Massage ou massagem tailandesa.

Ela faz parte de um sistema maior, a **Medicina Tradicional Tailandesa**, que inclui também a fitoterapia, a alimentação, as compressas de ervas (luk pra kob), a autoterapia com posturas (ruesi dat ton) e a dimensão espiritual do cuidado.

O país dos mantos amarelos

A Tailândia é conhecida como o **país dos mantos amarelos**, por causa do grande número de monges budistas presentes em todas as cidades. O budismo é a principal religião do país: segundo um censo de 1960, cerca de 94% da população se declarava budista, e o rei é coroado como protetor e guardião dessa fé.

Entender a Thai Massage é entender essa raiz. Antes mesmo de existir a Tailândia como a conhecemos, a doutrina do Buda, vinda da Índia, já era seguida pelos reinos que dominavam a região. E foi junto com ela que chegaram os conhecimentos de cura.

> AS INFLUÊNCIAS QUE FORMARAM A THAI MASSAGE
>
> - **Ayurveda e Yoga** (Índia): a ideia de canais de energia e os alongamentos posturais.
> - **Medicina chinesa**: o trabalho sobre pontos e o raciocínio de fluxo e bloqueio.
> - **Budismo Theravada**: a meditação, a atenção plena e a prática da compaixão (metta).
> - **Saberes locais**: a cultura Mon-Khmer, a massagem de família e os curandeiros das aldeias.

Uma tradição oral

Durante séculos, o conhecimento foi transmitido de forma oral e prática, nos mosteiros (wat) e dentro das famílias. Os monges dominavam a leitura e a escrita e eram, muitas vezes, os médicos da comunidade. Parte dos registros escritos se perdeu em 1767, quando a antiga capital Ayutthaya foi destruída durante a guerra com a Birmânia.

Índia, berço do Ayurveda

A Índia é um território de enorme riqueza histórica e espiritual, com vestígios de presença humana que remontam a cerca de 400.000 anos, às margens do rio Soan. É o berço do hinduísmo, do budismo, do jainismo e do siquismo, terra de Buda, Gandhi e Tagore. Deu ao mundo os algarismos que usamos, o conceito do zero e um dos sistemas médicos mais antigos da humanidade: o **Ayurveda**, considerado pelos indianos um saber recebido dos deuses.

A lenda dos rishis

Conta a tradição que, há cerca de seis mil anos, a Índia estava enferma. As pessoas sofriam de muitas doenças e os curandeiros não sabiam como ajudar. Um grupo de sábios decidiu então partir em peregrinação para as montanhas do Himalaia, onde meditaram e oraram em busca de inspiração para socorrer o povo.

Esses sábios são os **rishis**, palavra sânscrita que significa "videntes". Segundo a tradição, foi por meio de visões e diálogos com os antigos deuses que eles receberam o conhecimento que deu origem ao Ayurveda.

PRIMEIRO PILAR

A alimentação

Os rishis organizaram os alimentos em grupos e sabores e concluíram que, com eles, era possível prevenir, tratar e curar doenças. Por isso, alguns historiadores chamam os indianos de primeiros nutrólogos do mundo.

SEGUNDO PILAR

As plantas

Depois, catalogaram plantas e suas formas de uso. Esse conhecimento influenciou os sistemas médicos do Sudeste Asiático e de outras culturas vizinhas, entre eles a medicina tradicional tailandesa.

"O mesmo sopro de cuidado que nasceu no Himalaia chega hoje às suas mãos."

As raízes indianas

Para entender a Thai Massage é preciso voltar à Índia antiga. Os **rishis**, sábios da tradição védica, desenvolveram um sistema de cuidado que ia muito além dos remédios: técnicas manuais, massagem e outros tratamentos pelo toque, além da higiene, da hidratação e da manipulação da pele, dos músculos e das articulações.

Os indianos estiveram entre os primeiros povos a estudar anatomia de forma sistemática. Sabiam diferenciar artérias e veias, criaram instrumentos cirúrgicos e realizaram algumas das primeiras cirurgias da história, como reconstruções de nariz e orelhas. Essa medicina cuidava do corpo e também da mente, com uma dimensão espiritual voltada a acalmar o sofrimento.

No início, a cura era cercada de rituais, orações e mantras. Com o tempo, passou a integrar ervas, óleos e exercícios para os problemas comuns de saúde, registrados nos textos do **Atharva Veda**. É dessa base que nasce o **Ayurveda**.

"Brahma deu a cada planta um aroma e uma cor,
e o ser humano encontrou na natureza a sua farmácia."

LENDA VÉDICA

Conta uma lenda dos Vedas que, quando Brahma criou o mundo e o ser humano, o deus Indra temeu que as pessoas adoecessem e pediu que as plantas recebessem o poder de curar. Brahma atendeu ao pedido e deu a cada planta aromas e cores próprios. Assim o ser humano passou a usar as plantas em infusões, misturadas a óleos para massagear o corpo e aplicadas sobre a pele.

> **O ENCONTRO COM O BUDISMO**
>
> Por volta de 500 a.C., o budismo surgiu em Magadha, no norte da Índia, e influenciou o Ayurveda. Os rituais perderam espaço e os monges passaram a aprender e transmitir sobretudo a fitoterapia e as técnicas manuais. São esses monges que, segundo a história, levaram o conhecimento médico da Índia para a região então chamada de **Suvarnabhumi**, a Terra do Ouro. Mas a região já tinha seus próprios saberes de cura, enriquecidos por migrações e pelo comércio entre os povos.

Jivaka, o médico do Buda

O Buda, Sidarta Gautama, nasceu no norte da Índia, príncipe do reino de Kapilavastu. Abandonou o palácio em busca de compreender a causa do sofrimento humano e reuniu uma grande comunidade de monges, a **sangha**. Entre seus seguidores estava o rei **Bimbisara**, que governava o estado de Magadha.

Conta a tradição que, em Magadha, um recém-nascido foi deixado em uma caixa de madeira do lado de fora dos muros do palácio. O príncipe **Abhaya**, filho de Bimbisara, ouviu o choro ao voltar de viagem, recolheu a criança e decidiu criá-la como filho. Deu a ela o nome de **Jivaka Komarabhacca**, "aquele que foi criado pelo príncipe".

Curioso pela medicina, Jivaka foi estudar em **Taxila**, na região de Gandhara (atual Paquistão), um dos grandes centros de saber da época. Ali estudou por sete anos com um mestre de Ayurveda, conhecedor das plantas e da cirurgia.

"Não encontrei nenhuma planta que não tivesse poder de curar."

A PROVA FINAL DE JIVAKA

No fim dos estudos, o mestre pediu a Jivaka uma última tarefa: percorrer as colinas de Taxila e trazer todas as plantas que não tivessem nenhuma utilidade medicinal. Depois de dias observando a flora, ele voltou de mãos vazias. O mestre sorriu, deu a ele algumas moedas para a viagem de volta e disse que não havia mais nada a ensinar.

De volta a Magadha, Jivaka tornou-se médico do rei Bimbisara, do próprio Buda e da comunidade de monges. Os textos do budismo Theravada contam que foi ele quem tratou o pé do Buda quando este foi ferido por uma pedra. Tornou-se o médico mais renomado da Índia de seu tempo.

> SHIVAGO KOMARPAJ
>
> Na Tailândia, pela pronúncia local, Jivaka é chamado de **Shivago** e venerado como homem santo e **pai da medicina tailandesa**. Até hoje as escolas de Thai Massage recitam mantras em sua honra antes e ao final de cada aula e de cada atendimento. Os historiadores consideram essa ligação mais simbólica do que documental, mas ela dá sentido ao gesto: cada sessão honra uma linhagem de cuidadores.

O budismo chega à Tailândia

Após a morte do Buda, um concílio dividiu a comunidade em duas grandes correntes. A **Mahayana** se espalhou em direção à China e ao norte da Ásia. A **Theravada**, a "doutrina dos anciãos", manteve a disciplina monástica mais próxima dos ensinamentos originais. É a Theravada que chegou ao Sudeste Asiático e que predomina até hoje na Tailândia.

Existem diferentes relatos sobre essa chegada. Um deles, registrado no **Mahavamsa** (as crônicas budistas do Sri Lanka), remete ao imperador indiano **Ashoka** (274 a 232 a.C.), que enviou missionários às nove regiões do mundo então conhecido. Além do conhecimento espiritual, esses monges levavam também conhecimentos médicos, que se misturaram às tradições locais.

SUVARNABHUMI

A Terra do Ouro

Uma das regiões que receberam os missionários de Ashoka. Abrangia partes dos atuais Myanmar, Tailândia, Camboja e Laos. Para lá foram enviados os monges **Sona e Uttara**, vindos de Magadha. A cultura Mon-Khmer que prosperava ali acolheu a filosofia budista.

DVARAVATI

A Primeira Cidade

O antigo reino Dvaravati ocupava a região central da Tailândia e tinha como capital a atual **Nakhon Pathom**, do páli *Nagara Pathamam*, "Primeira Cidade". É considerada a cidade mais antiga do país e foi onde o budismo se firmou antes de se espalhar por todo o território.

A Roda do Dhamma

Nas escavações em Nakhon Pathom e arredores foram encontradas grandes rodas de pedra, a **Dharmachakra** ou Roda do Dhamma, símbolo do ensinamento do Buda. Elas são usadas como marco histórico da chegada do budismo à Tailândia e reforçam a tese de que o conhecimento trazido pelos monges da Índia está na origem da medicina tailandesa e da Thai Massage. Uma delas está exposta no Museu de Korat, em Nakhon Ratchasima.

> DO SUL AO NORTE
>
> Hoje, o centro de Bangkok guarda o templo de Wat Pho, berço da escola do sul. Ao norte, **Chiang Mai** concentra escolas, hospitais de medicina tradicional e retiros de formação, e é destino frequente de quem vai estudar a Thai Massage na fonte.

Linha do tempo

Séculos VI a V a.C.

Vida do Buda e de Jivaka Komarabhacca (Shivago), o médico do Buda, considerado pela tradição o pai da medicina tailandesa.

Século III a.C.

O imperador Ashoka envia missionários budistas Theravada a nove regiões, entre elas Suvarnabhumi, a Terra do Ouro.

Reino Dvaravati

O budismo se firma na região central, com capital em Nakhon Pathom. A Roda do Dhamma marca esse período.

1767

Queda de Ayutthaya. Muitos textos de medicina tradicional são destruídos e a transmissão volta a depender ainda mais da tradição oral.

Rama I

Reorganização do saber médico, incluindo o texto Tamra Loke Nitan, uma das fontes que descrevem o trajeto das linhas Sen.

Rama III, século XIX

No templo de Wat Pho, em Bangkok, o conhecimento médico é gravado em placas de pedra, com diagramas do corpo, das linhas e dos pontos de massagem. O templo recebe também as estátuas dos eremitas em autoalongamento (ruesi dat ton).

Rama V

O Texto Real de Medicina Tradicional Tailandesa padroniza nomes e trajetos das linhas usados até hoje.

Século XX

Surgem as escolas formais, em Bangkok e em Chiang Mai. A prática se organiza em currículos e passa a ser ensinada a estrangeiros, chegando ao Ocidente e ao Brasil.

2019

A UNESCO inscreve o **Nuad Thai** na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

MÓDULO 01 · HISTÓRIA

Da aldeia ao hospital

No passado, uma prática dos vilarejos, passada de geração em geração. No século XX, o governo tailandês passou a pesquisar e reconhecer oficialmente essa tradição.

1983
O governo cria um projeto de revitalização da técnica, com intercâmbio de conhecimentos entre os praticantes e um sistema de ensino no país.

1987
Primeiros ensaios clínicos e início da implantação da massagem em hospitais.

1993
Uma lei troca o termo "antigo" por "tradicional": a *Nuad Pan Boran* passa a ser *Nuad Pan Thai*, hoje simplesmente **Nuad Thai**. No mesmo ano, o governo realiza o primeiro curso oficial de formação, com 330 horas, que forma 500 terapeutas.

24 de setembro de 2001
O "Dia D": o Ministério da Saúde da Tailândia reconhece a Thai Massage como parte integrante da medicina tradicional, abrangendo avaliação, tratamento, prevenção, promoção da saúde e reabilitação.

2007
Uma resolução garante o reembolso das sessões realizadas em unidades de saúde credenciadas. A técnica passa a integrar a atenção primária à saúde pública do país.

A DEFINIÇÃO OFICIAL

Para o Ministério da Saúde Pública da Tailândia, o Nuad Thai é a integração da ciência e da arte no cuidado tradicional em saúde: pressionar, girar, amassar, apertar, alongar, puxar, aplicar compressas de ervas quentes e manipular pontos específicos ao longo das vias energéticas para restaurar o fluxo de energia e a circulação, aliviando dor, rigidez, tensão e outros sintomas.

Duas formas de Nuad Thai

NUAD RAKSA

Nuad Thai terapêutico

Uso clínico, baseado em pontos e linhas, como terapia complementar para queixas específicas. É a raiz da Thai Massage Clínica.

NUAD PHUA SUKAPHAP

Promoção da saúde

Voltado ao relaxamento, ao bem-estar e à melhora geral da saúde.

MÓDULO 01 · HISTÓRIA

As duas grandes escolas

Embora exista uma base comum, a Thai Massage se desenvolveu com sotaques regionais. Os dois estilos mais conhecidos são o do sul (Bangkok) e o do norte (Chiang Mai).

SUL · BANGKOK

Estilo Wat Pho

Ritmo mais firme e dinâmico, pressões mais profundas com polegares e palmas, trabalho preciso sobre linhas e pontos. Muito usado com foco terapêutico.

NORTE · CHIANG MAI

Estilo do norte

Ritmo mais lento e envolvente, ênfase em alongamentos amplos e balanços, uso generoso do peso do corpo, joelhos e pés. Sensação de fluidez e entrega.

Da tradição à clínica

Herdeira do **Nuad Raksa**, a **Thai Massage Clínica** preserva a essência da tradição (o respeito, o ritmo, a atenção plena) e acrescenta o raciocínio terapêutico: escuta da queixa, avaliação da postura e da mobilidade, escolha das manobras pelo objetivo e reavaliação ao final.

Avaliar

Ouvir a queixa, observar postura, testar amplitude e identificar contraindicações.

Escolher

Selecionar as manobras pelo objetivo da sessão, não por uma sequência fixa.

Reavaliar

Comparar antes e depois e orientar o cliente para o autocuidado.

> REFLEXÃO
>
> Conhecer a história não é só curiosidade cultural. Quando você conta ao seu cliente de onde vem a técnica, você transforma uma sessão em uma experiência, e o cliente percebe o valor do que recebe.

02

MÓDULO

Fundamentos teóricos

Os canais por onde flui o vento vital, os elementos que compõem o corpo e a atitude de coração que sustenta cada toque.

MÓDULO 02 · FUNDAMENTOS

Lom pran e as linhas Sen

A teoria tradicional descreve o corpo atravessado por uma rede de canais, as **linhas Sen**, por onde circula **lom pran**, o vento vital. Fala-se em 72.000 linhas, das quais **dez são as principais** (Sen Sip). Quase todas nascem ao redor do umbigo, a uma distância medida em *onculis* (a largura de uma falange do dedo do próprio cliente), e terminam em um ponto de exteriorização: narinas, olhos, ouvidos, dedos, língua ou orifícios do baixo ventre.

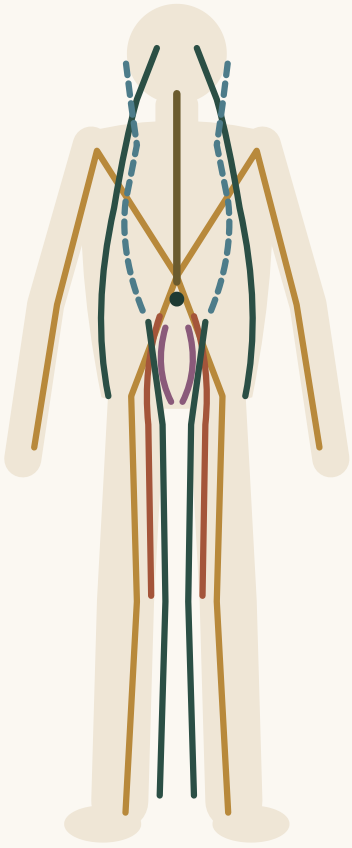
Quando o vento flui livre, há saúde. Quando é perturbado pelo **Chakala Wayo**, o "vento ruim", o desequilíbrio aparece primeiro nos músculos (dor nas costas, no pescoço, na lombar, dor de cabeça de origem occipital), depois no plano energético e funcional e, se persistir, pode chegar a alterações orgânicas. As dores costumam vir acompanhadas de componentes emocionais, como insegurança e medo.

LINHA	ORIGEM E TRAJETO RESUMIDO	EXTERIORIZAÇÃO
Sumana	2 onculis acima do umbigo, sobe pelo esterno até a língua	Língua e garganta
Itha	2 onculis à esquerda do umbigo, desce a perna, sobe pela parte posterior até a cabeça	Narina esquerda
Pingkhala	Espelho de Itha, à direita	Narina direita
Kalathari	1 onculi acima do umbigo, cruza o tronco e vai para braços e pernas	Dedos das mãos e dos pés
Sahatsarangsi	4 onculis à esquerda do umbigo, percorre a perna e sobe até o rosto	Olho esquerdo
Tawaree	Espelho de Sahatsarangsi, à direita	Olho direito
Lawusang	6 onculis à esquerda do umbigo, sobe pelo tronco e pescoço	Ouvido esquerdo
Ulangka	Espelho de Lawusang, à direita	Ouvido direito
Nanthakrawat	Também chamada Sukumang. Abaixo e à esquerda do umbigo	Ânus
Kitchana	Também chamada Sikhinee. Abaixo e à direita do umbigo	Uretra

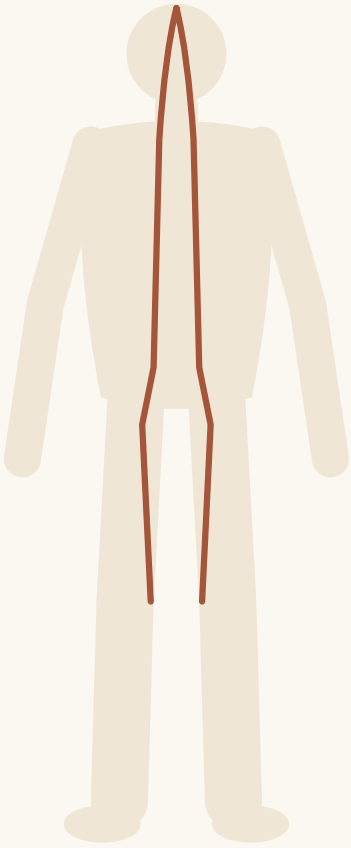
> PARA A PRÁTICA CLÍNICA
>
> Você não precisa "acreditar" em energia para usar o mapa das Sen. Muitos trajetos coincidem com septos musculares, feixes neurovasculares e cadeias miofasciais. Use o mapa como guia de onde e em que direção trabalhar.

Mapa das linhas principais

Ilustração esquemática para estudo. Os trajetos variam entre as fontes tradicionais (Wat Pho, Tamra Loke Nitan e Texto Real de Rama V).



FRENTE



COSTAS

- **Itha e Pingkhala**: descem pelas pernas, contornam o joelho e sobem pela parte posterior, ao lado da coluna, até as narinas.
- **Sahatsarangsi e Tawaree**: percorrem a perna e o pé, sobem pelo tronco e pescoço até os olhos.
- **Nanthakrawat e Kitchana**: baixo ventre, para ânus e uretra.
- **Umbigo**: o centro de onde nascem as linhas.
- **Kalathari**: linha cruzada que liga as cinturas escapular e pélvica aos dedos.
- **Lawusang e Ulangka**: trajeto curto, do abdômen ao ouvido.
- **Sumana**: linha central, do esterno até a língua.

As linhas em detalhe

Sumana

A linha central. Começa 2 onculis acima do umbigo, passa sobre o esterno e sobe até a língua. Nas placas de Wat Pho aparece ligada ao ponto **Chiwhasadom**, que governa a língua, a boca e os cinco sabores.

Indicações: problemas respiratórios como asma e bronquite, gripe e tosse, dor de cabeça, dor de garganta, dor no peito e problemas cardíacos, náusea e dor abdominal, dores nas costas e crises emocionais de ansiedade, angústia e tristeza. Os principais órgãos estimulados são os intestinos, o coração, os pulmões e os órgãos reprodutores.

O ESTERNO E A CADEIA POSTURAL

O esterno é ponto-chave para a respiração e para a posição da cabeça. Quando os músculos que se ligam a ele encurtam, o peito se fecha, os ombros giram para dentro e a coluna torácica arredonda (cifose), reduzindo a expansão das costelas. A cabeça vai à frente, comprime a região entre o occipital e as cervicais e obriga músculos como o **levantador da escápula** a trabalhar em excesso, gerando dores de cabeça e tensão no pescoço. Para compensar, o quadril bascula à frente (anteversão), sobrecarregando a lombar e comprimindo os órgãos abdominais. Liberar a linha Sumana é abrir o peito e devolver espaço à respiração.

Itha e Pingkhala

Representam a dualidade: esquerda e direita, lunar e solar, frio e quente. Pelo equilíbrio entre essas forças opostas, elas harmonizam os elementos, o que a medicina tailandesa chama de **Som Dun**. Partem de 2 onculis ao lado do umbigo, descem pelas pernas, contornam o joelho, sobem pela coxa até os glúteos e seguem pelas costas, ao lado da coluna (sacro, lombar, torácica, cervical), passando pela cabeça até as narinas. São regidas pelo vento **Asasa Pasasa Wata**, que nasce entre o esterno e o umbigo e se dirige às narinas. Nas placas de Wat Pho, Itha é chamada de **Jantala Kala** (lunar) e Pingkhala de **Surya Kala** (solar), e cada linha tem 36 pontos descritos, na frente e nas costas.

DICA CLÍNICA

Dificuldade para flexionar o tronco à frente: trabalhe a **linha 2** das costas. Dificuldade para estender (curvar para trás): trabalhe a **linha 1**. Desequilíbrios típicos: dor ao longo do trajeto, alterações de temperatura e distúrbios nasais.

Kalathari

Linha cruzada. Começa 1 onculi acima do umbigo e se divide em duas linhas superiores e duas inferiores, em diagonal, formando um X na frente do corpo. As inferiores descem pela parte interna da coxa (adutores) e pela perna, junto à tíbia, até os pés, onde se abrem em cinco linhas. As superiores vão aos ombros, passam pelo deltoide anterior e descem pela parte interna dos braços até a palma, abrindo-se para os cinco dedos.

Influencia as duas grandes cinturas do corpo (pélvica e escapular) e muitas articulações. É usada nos desajustes articulares e no movimento dos dedos. Os textos antigos também a relacionam a desordens mentais e emocionais. Existem três traçados descritos: o dos diagramas de Wat Pho, o do Tamra Loke Nitan (reinado de Rama I) e o do Texto Real de Rama V, que inclui um ramo pelas costas, dos ombros até a lombar.

Sahatsarangsi e Tawaree

Também chamadas Hadsarangsi e Tawaree. Nascem a 4 onculis do umbigo, descem pela parte medial da coxa ao lado do reto femoral, seguem junto à tíbia, contornam o maléolo medial e percorrem a sola do pé (arco medial, base dos dedos, arco lateral). Voltam por trás do maléolo lateral, sobem pela lateral da perna e da coxa até a crista ilíaca, passam sob as costelas até o mamilo, a clavícula, o esternocleidomastoideo e a lateral do rosto, até o olho.

Indicações: olhos secos, cansados ou irritados, dor e instabilidade no joelho, formigamento e dificuldade de movimento nas pernas, dor no tibial anterior, paralisia facial, dor cervical e torcicolo, desconforto respiratório e diafragmático, dor de garganta e de dente.

Nas placas de Wat Pho

Os diagramas de Wat Pho mostram as dez linhas na frente e nas costas do corpo, com os pontos onde cada uma "vem para fora", ou seja, onde fica mais sensível à palpação e onde seus desequilíbrios se manifestam. Além das linhas, as placas citam:

Amapluk	Região do vento ligada à paralisia e à perda de movimento das pernas
PithaKhun	Vento da região pélvica
Chiwhasadom	Ponto de equilíbrio dos cinco sabores, ligado à língua, à boca e a Sumana
Ananta Jakrawata	Ponto de concentração descrito na frente do corpo

Lawusang e Ulangka

Nascem a 6 onculis do umbigo (Lawusang à esquerda, Ulangka à direita) e têm trajeto curto: sobem até o mamilo, passam pelo terço médio da clavícula, sobem pelo pescoço por trás do esternocleidomastoideo, contornam a orelha e terminam no trago, na altura da articulação temporomandibular. Em Wat Pho aparecem com os nomes **Jantapusang e Rucham**, usados nos diagramas da época de Rama III.

Indicações: dores de ouvido, zumbido, dificuldade de audição, problemas vestibulares e vertigem, disfunção da ATM, dor de dente, insônia e paralisia facial.

Nanthakrawat e Kitchana

Também chamadas Sukumang e Sikhinee. Nascem 2 onculis ao lado e 2 abaixo do umbigo. Nanthakrawat (à esquerda) segue para o ânus e Kitchana (à direita) para a uretra. Relacionam-se com a digestão, a eliminação e o sistema urogenital.

Os pontos de Wat Pho

As placas de Wat Pho descrevem pontos de acupressão ao longo de cada linha, com sua indicação. Como exemplo, estes são os 18 pontos da **linha Itha**, na parte frontal do lado esquerdo do corpo:

1	Perda do olfato e dificuldade de respirar pelo nariz	10	Dor na região temporal
2	Estalos e travamento da mandíbula ao bocejar	11	Dor aguda na escápula
3	Dificuldade e perda progressiva de audição	12	Cãibras e dormência na parte posterior da coxa e no adutor magno
4	Ingurgitamento mamário	13	Inflamação de gânglios linfáticos, apoio à próstata
5	Tensão e dores nas coxas	14	Constipação
6	Desconforto na parte interna do joelho	15	Movimento do cólon descendente
7	Pernas cansadas e doloridas	16	Dormência e frio no pé
8	Vento (lom pran) bloqueado no quadril e nas pernas	17	Cãibras agudas
9	Dor, inflamação ou calor na sola do pé	18	Movimentos involuntários do pé (clônus)

> **ATENÇÃO**
>
> O ponto 15 é tradicionalmente associado ao trabalho de parto. Por isso, pontos abdominais e da linha Itha devem ser evitados em gestantes.

Os quatro elementos (Thatu)

Na Medicina Tradicional Tailandesa, o corpo é formado por quatro elementos. O desequilíbrio entre eles explica boa parte dos sintomas, e a massagem é uma das formas de devolver a harmonia. Cada elemento tem seu número auspicioso, seguindo a mística do budismo tailandês.

ดิน

Terra (Din)

Estrutura: ossos, músculos, tendões, órgãos. Associada ao número 20. Excesso traz rigidez e peso; falta traz fraqueza.

น้ำ

Água (Nam)

Os líquidos do corpo, tradicionalmente 12: bile, muco, linfa, sangue, suor, gordura, lágrimas, saliva, secreção nasal, líquido sinovial, urina, entre outros.

ลม

Vento (Lom)

Movimento: respiração, circulação, impulsos nervosos. É o elemento mais trabalhado pela massagem.

ไฟ

Fogo (Fai)

Calor e transformação: metabolismo, digestão, temperatura do corpo, envelhecimento.

Os elementos no abdômen



vista de frente para o cliente

Um diagrama de Wat Pho mostra **doze pontos ao redor do umbigo** ligados aos elementos. Os quatro principais indicam excesso ou estagnação:

- **Abaixo do umbigo:** vento em excesso
- **Acima do umbigo:** fogo em excesso
- **À direita do umbigo:** água estagnada
- **À esquerda do umbigo:** terra estagnada

Direita e esquerda do cliente. O trabalho abdominal exige formação específica, pressão suave e respeito às contraindicações.

As quatro atitudes do coração

A Thai Massage nasce dentro de uma tradição budista. Por isso, a qualidade interna do terapeuta é tão importante quanto a técnica. Os **Brahmaviharas** são quatro estados que guiam o atendimento:

Metta

Bondade amorosa. Desejar genuinamente o bem de quem você atende.

Karuna

Compaixão. Perceber o sofrimento do outro e agir para aliviá-lo.

Mudita

Alegria compartilhada. Celebrar a melhora e o bem-estar do cliente.

Upekkha

Equanimidade. Estar presente sem julgamento e sem apego ao resultado.

Wai Khru: a homenagem aos mestres

Antes de cada atendimento, o terapeuta faz o **Wai Khru**: um momento de silêncio, mãos unidas diante do peito, em respeito a Shivago e a todos os mestres que mantiveram viva essa tradição. Nas escolas tailandesas, esse momento é acompanhado de um mantra em páli recitado no início e no fim de cada aula.

Mesmo em um atendimento clínico, esse gesto tem função prática: é a pausa que separa o que veio antes da sessão e coloca você inteira no cuidado que vai começar.

"A massagem é meditação em movimento,
para quem recebe e para quem aplica."

A postura do terapeuta

Na Thai Massage, a força não vem dos braços. Ela vem do **peso do corpo**, transferido com o quadril e o centro. Um terapeuta bem posicionado trabalha com profundidade e sem se machucar.

- **Base estável:** joelhos afastados, coluna neutra, ombros relaxados.
- **Braços retos:** cotovelos estendidos, a pressão nasce da inclinação do tronco.
- **Movimento a partir do centro** (hara): o quadril conduz, as mãos apenas transmitem.
- **Proximidade:** fique perto do cliente. Distância obriga você a usar força muscular.
- **Pausas e trocas de apoio:** mude de posição antes de sentir desconforto.

As ferramentas do corpo

FERRAMENTA	QUALIDADE DO TOQUE	USO MAIS COMUM
Palmas	Ampla, acolhedora, aquece	Abertura, pressões ao longo das linhas
Polegares	Precisa e profunda	Pontos e trabalho detalhado nas Sen
Antebraços	Larga e firme	Costas, coxas, glúteos
Cotovelos	Muito profunda, pontual	Glúteos, região plantar (com cautela)
Joelhos	Peso estável	Coxas e pernas em alongamentos
Pés	Ampla, com peso total	Pernas, glúteos e alongamentos de tração

Ritmo, respiração e pressão

Ritmo

Lento, constante e previsível. O corpo relaxa quando sabe o que vem a seguir. Pressione, sustente, solte.

Respiração

Aprofunde a pressão na expiração do cliente. Respire junto com a pessoa e use a sua respiração para se manter presente.

> ESCALA DE PRESSÃO
>
> Combine com o cliente uma escala de 0 a 10. Trabalhe entre 5 e 7, a "dor boa". Acima disso, o corpo se defende e a técnica perde o efeito.

Estrutura de uma sessão

A ordem tradicional percorre o corpo dos pés à cabeça, passando por diferentes posições. Na abordagem clínica, essa estrutura é uma referência, adaptada ao objetivo de cada atendimento.

1 · Acolhimento

Anamnese, avaliação e combinados. Wai Khru: um momento de silêncio e intenção antes de tocar.

2 · Decúbito dorsal (barriga para cima)

Pés, pernas e linhas das pernas, alongamentos de quadril, abdômen (com cautela), braços e mãos.

3 · Decúbito lateral

Linhas laterais da perna, quadril, região lombar, ombro e torções suaves.

4 · Decúbito ventral (barriga para baixo)

Parte posterior das pernas, glúteos, costas e alongamentos em extensão.

5 · Sentado

Ombros, trapézio, pescoço, torções e alongamentos do tronco.

6 · Cabeça e face

Couro cabeludo, face e encerramento em repouso.

7 · Fechamento

Reavaliação, orientação de autocuidado e registro na ficha do cliente.

> AMBIENTE
>
> Futon firme no chão, roupa confortável para o cliente (sem óleo), sala aquecida e silenciosa, almofadas para apoio. Mãos limpas, unhas curtas e celular fora do alcance.

Segurança em primeiro lugar

Todo atendimento começa com uma **anamnese**. Ela protege o cliente, protege você e orienta a escolha das manobras. Na dúvida, não aplique e peça liberação médica.

CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS (NÃO ATENDER)

- Febre, infecção aguda ou doença contagiosa
- Trombose venosa profunda atual ou suspeita
- Fraturas recentes, entorses agudas, inflamação aguda
- Pós-operatório recente sem liberação médica
- Feridas abertas, queimaduras, lesões de pele na área
- Hipertensão grave não controlada, problema cardíaco descompensado
- Cliente sob efeito de álcool ou drogas

CONTRAINDICAÇÕES RELATIVAS (ADAPTAR OU PEDIR LIBERAÇÃO)

- **Gestação:** evitar decúbito ventral, abdômen, pontos específicos e alongamentos intensos. Atender só com formação específica.
- **Osteoporose:** pressões leves, sem alongamentos com alavanca grande.
- **Hérnia de disco e dor lombar aguda:** evitar torções e extensões forçadas.
- **Varizes:** não pressionar diretamente sobre os vasos.
- **Próteses articulares:** respeitar a amplitude orientada pelo médico.
- **Anticoagulantes, diabetes com neuropatia, câncer:** pressão leve e liberação médica.
- **Idosos frágeis e hipermobilidade:** alongamentos suaves, sem forçar o fim da amplitude.

Regiões de cuidado especial

Evite pressão direta e prolongada sobre: parte de trás do joelho (fossa poplítea), região anterior do pescoço, axilas, virilha (artéria femoral), coluna vertebral sobre os processos espinhosos, abdômen em quem comeu há pouco e rins.

A técnica tradicional de "bloqueio do fluxo" na artéria femoral (blood stop) **não deve ser aplicada** em hipertensos, cardiopatas, gestantes, diabéticos, pessoas com varizes ou histórico de trombose.

O raciocínio clínico

Uma sessão clínica não é uma sequência decorada. É uma resposta a uma pergunta: **"o que este corpo precisa hoje?"**

1. Escutar

Qual é a queixa? Desde quando? O que piora e o que melhora? Há diagnóstico médico?

2. Observar

Postura em pé, assimetrias, padrão de marcha, como a pessoa se senta e se deita.

3. Testar

Amplitude de movimento antes da sessão: flexão de quadril, rotação de tronco, inclinação do pescoço.

4. Planejar

Defina 1 ou 2 objetivos e escolha as manobras que servem a eles.

5. Aplicar

Com comunicação constante. Pergunte, observe a respiração e a expressão facial.

6. Reavaliar

Repita os testes. Mostre ao cliente a diferença. Oriente o autocuidado.

Sinais para parar ou ajustar

- Dor aguda, em choque ou que irradia
- Formigamento, dormência ou mudança de cor na extremidade
- Tontura, náusea, palidez ou suor frio
- Respiração presa, tensão de defesa, expressão de desconforto
- Emoção intensa: pause, acolha e pergunte se a pessoa quer continuar

> ÉTICA E CONSENTIMENTO
>
> Explique antes o que vai fazer, principalmente nos alongamentos com contato amplo. O cliente pode interromper a qualquer momento. Registre cada atendimento na ficha.

MÓDULO 05

Catálogo de manobras

Cada manobra em uma ficha: a imagem da aula, a posição, o objetivo e o passo a passo para você praticar com segurança.

A aula prática

As fichas a seguir reproduzem a sequência demonstrada no workshop de Thai Massage Clínica, com foco nas queixas que quase todo cliente traz: **dor lombar, dor no trapézio e dor de cabeça**. A sessão percorre quatro posições: decúbito dorsal, ventral, lateral e sentado.

Cada ficha traz a posição do cliente e do terapeuta, a região, a ferramenta, o objetivo, os cuidados e o passo a passo. O tempo indicado no topo leva ao trecho da aula em vídeo. No livro de referência, o cliente é chamado de **interagente**: ele participa da sessão com a respiração e o movimento.

Os princípios da Yumi

Não é força, é jeito

Trabalhe com o peso do corpo, cotovelos esticados e o movimento vindo do quadril. É isso que permite atender várias pessoas no dia sem se cansar.

1, 2, 3 para entrar

Entre em cada manobra contando 1, 2, 3 e saia do mesmo jeito. Pressão que chega de repente assusta e dói mais.

Pegue perto da articulação

Quanto mais perto da articulação você segura, menos força faz. Quanto mais longe, maior a alavanca.

Ajuste o seu corpo

Se está ruim para você, está ruim para o cliente. Cada corpo pede um encaixe diferente: com cliente grande, fique em pé, abrace, mude a pegada.

Respire junto

Acompanhe a respiração do cliente. Em poucos movimentos ele entra no seu ritmo.

Foque na dor

Você não precisa fazer todas as manobras. Escolha as que tratam a queixa. Faça de três a seis repetições de cada uma, conforme a resposta do cliente.

> ESCALA DE DOR
>
> Pergunte: "de 0 a 10, quanto está?". Trabalhe até 7. Em pessoas sensíveis, fique entre 3 e 4. Observe sempre o rosto do cliente.

Antes do primeiro toque

1. Desperte o seu corpo

Entre um cliente e outro, reserve cerca de meia hora para arrumar a sala, higienizar e cuidar do seu corpo. Comece sempre ativando o corpo, porque quem trabalha muito em pé sobrecarrega pernas, quadril e lombar.

- **Respiração:** olhos fechados, inspire pelo nariz e solte pela boca, trazendo presença.
- **Cervical:** círculos lentos com a cabeça para os dois lados; queixo no peito com as mãos atrás da cabeça; inclinação lateral.
- **Coluna:** crescer como se alguém puxasse você para cima e depois descer o tronco em direção ao chão, voltando devagar com a cabeça por último.
- **Quadril:** sentado, faça círculos sentindo os ísquios no chão.
- **Ombros:** eleve os ombros até as orelhas e solte. Termine abraçando o próprio corpo.

"Primeiro o autocuidado. Respeite os seus limites para saber respeitar os do outro."

2. Coloque a intenção

Na tradição, a sessão começa com o **Wai Khru**, a homenagem a Shivago e aos mestres. No dia a dia, isso pode ser feito em silêncio: una as mãos, aqueça-as e mentalize a intenção de ser instrumento de cura, para que a pessoa saia melhor do que entrou. Cada cliente tem a sua crença; a intenção é sua e não precisa ser dita em voz alta.

3. Prepare o espaço

A Thai Massage é feita com o cliente vestido, com roupas confortáveis. Pode ser feita em um futon, em um tapete de yoga ou até sobre uma toalha. Tudo também pode ser adaptado para a maca, de preferência com 80 cm de largura, o que ajuda muito no atendimento de idosos.

Decúbito dorsal

Cliente deitado de barriga para cima. A sequência é feita primeiro em uma perna e depois repetida, igual, na outra, para o corpo não ficar desequilibrado.

- **01** Avaliação dos pés e tornozelos
- **02** Pressão palmar nos pés
- **03** Caminhada palmar na parte interna da perna
- **04** Pedalinho: mobilidade de quadril
- **05** Infinito: posterior e interno da coxa
- **06** Sanduíche: tração lombar
- **07** Tripé: avanço na perna flexionada
- **08** Compasso: abertura do quadril
- **09** Torção e alongamento transversal
- **10** Balanço diagnóstico
- **11** Tração da perna em pé
- **12** Alongamento posterior em 4
- **13** Pés na crista: joelhos ao chão
- **14** Tração do trapézio

DECÚBITO DORSAL

01 Avaliação dos pés e tornozelos

Vídeo 0:51:30



CLIENTE	Deitado de barriga para cima, pernas estendidas.
TERAPEUTA	Ajoelhado aos pés do cliente.
REGIÃO	Pés, tornozelos, joelhos e quadril.
FERRAMENTA	Mãos.
OBJETIVO	Sentir a mobilidade e comparar os dois lados antes de começar. O lado mais preso recebe mais atenção.
CUIDADOS	Movimento solto, sem forçar. É avaliação, não tratamento.

PASSO A PASSO

1. Una as mãos e aqueça-as, mentalizando a intenção da sessão.
2. Segure os pés e mobilize os tornozelos com balanços leves.
3. Compare os lados: o que resiste mais indica onde trabalhar mais (tornozelo, joelho ou quadril).

DECÚBITO DORSAL

02 Pressão palmar nos pés

Vídeo 0:53:06



CLIENTE	Deitado de barriga para cima.
TERAPEUTA	Ajoelhado aos pés, cotovelos estendidos.
REGIÃO	Planta e dorso dos pés.
FERRAMENTA	Palmas, com a base da mão (o "gordinho").
OBJETIVO	Primeiro contato: o cliente sente o toque e o terapeuta começa a perceber o que está em desequilíbrio.
CUIDADOS	Use o peso do corpo, não a força dos braços.

PASSO A PASSO

1. Ponto 1 no calcanhar, ponto 2 no meio do pé, ponto 3 próximo dos dedos.
2. Pressione para baixo com a base da mão e volte: 1, 2, 3, 2, 1.
3. Caminhe de um pé para o outro, transferindo o peso como numa dança, sempre com os cotovelos esticados.
4. Termine com as duas mãos juntas nos três pontos.

DECÚBITO DORSAL

03 Caminhada palmar na parte interna da perna

Vídeo 0:54:24



CLIENTE	Deitado, perna levemente rodada para fora.
TERAPEUTA	Ajoelhado ao lado da perna, quadril elevado.
REGIÃO	Face interna da perna e da coxa.
FERRAMENTA	Palma espalmada, polegar para cima.
OBJETIVO	Soltar a musculatura interna da perna e relaxar o cliente.
CUIDADOS	No joelho não há pressão, só um círculo. Observe o rosto do cliente e ajuste a pressão.

PASSO A PASSO

1. Do calcanhar, suba pela parte interna da perna com pressão palmar, devagar, "como um elefante".
2. No joelho, faça um movimento circular para fora, sem pressão.
3. Continue até próximo da virilha, sustente e conte até três ou quatro.
4. Volte caminhando pelo mesmo trajeto. Se a pressão estiver forte, leve o peso mais para o joelho de apoio.

DECÚBITO DORSAL

04 Pedalinho: mobilidade de quadril

Vídeo 0:59:15



CLIENTE	Deitado, perna flexionada.
TERAPEUTA	Sentado entre as pernas do cliente, segurando o tornozelo.
REGIÃO	Quadril e parte interna da coxa.
FERRAMENTA	Pés (empurram) e mão (puxa e solta).
OBJETIVO	Mobilizar o quadril com movimento rítmico, sem esforço do terapeuta.
CUIDADOS	Ajuste a amplitude à mobilidade do cliente e ao seu tamanho.

PASSO A PASSO

1. Segure o tornozelo do cliente e apoie um pé próximo ao joelho dele, na parte interna.
2. Empurre a cerca de 45 graus até a perna dobrar.
3. Alterne os pés como se pedalasse: um pé empurra enquanto a mão solta, o outro vem enquanto a mão puxa.
4. Vá subindo pela coxa até perto da virilha.

DECÚBITO DORSAL

05 Infinito: posterior e interno da coxa

Vídeo 1:02:31



CLIENTE	Deitado, perna cruzada sobre a perna do terapeuta.
TERAPEUTA	Sentado, joelho levemente dobrado para fora, formando um "8" com a perna do cliente.
REGIÃO	Posterior e parte interna da coxa.
FERRAMENTA	Planta do pé; a lateral do pé para mais pressão.
OBJETIVO	Trabalhar a musculatura posterior, ótima para quem corre, escala ou joga futebol.
CUIDADOS	Entre e saia contando 1, 2, 3. Se o quadril do cliente sai do chão, há compensação: diminua.

PASSO A PASSO

1. Encaixe o pé esquerdo próximo ao joelho, jogue seu joelho para fora e traga a perna do cliente por cima, travando-a.
2. Apoie o calcanhar do cliente com a mão, só para manter uma leve tensão.
3. Com o outro pé, pressione a coxa em dois a cinco pontos, conforme o tamanho do cliente.
4. Para mais intensidade, use a lateral do pé, "como uma faca".

DECÚBITO DORSAL

06 Sanduíche: tração lombar

Vídeo 1:04:10



CLIENTE	Deitado, joelho dobrado, calcanhar perto do glúteo.
TERAPEUTA	Ajoelhado, prendendo o pé do cliente entre os joelhos.
REGIÃO	Lombar, por meio da tração da perna.
FERRAMENTA	Mãos próximas ao joelho e peso do corpo.
OBJETIVO	Tracionar a lombar. Muitas vezes a coluna estala só com esse movimento.
CUIDADOS	Quanto mais longe da articulação a pegada, maior a alavanca. Comece com pouco.

PASSO A PASSO

1. Traga o calcanhar o mais perto possível do glúteo.
2. Prenda o pé do cliente entre os seus joelhos (o "sanduíche").
3. Segure a coxa próximo ao joelho, estique os braços e leve o seu corpo para trás.
4. Mantenha a tração e faça várias pequenas trações, inclusive levemente para dentro e para fora.

DECÚBITO DORSAL

07 Tripé: avanço na perna flexionada

Vídeo 1:05:49



CLIENTE	Deitado, joelho em direção ao peito.
TERAPEUTA	Em afundo, pé ao lado do quadril do cliente, o pé dele apoiado na sua crista ilíaca.
REGIÃO	Quadril e glúteo.
FERRAMENTA	Mão de dentro (três pontos) e o peso do corpo.
OBJETIVO	Destravar e mobilizar o quadril.
CUIDADOS	A mão de fora é só apoio, sem força.

PASSO A PASSO

1. Apoie o pé do cliente na dobra do seu quadril.
2. Com a mão de dentro, apoie em três pontos da coxa: perto da virilha, no meio e perto do joelho.
3. Faça um avanço, como na academia, levando o joelho do cliente em direção ao peito, e volte.
4. Ajuste o seu pé para a frente se o cliente tiver muita mobilidade.

DECÚBITO DORSAL

08 Compasso: abertura do quadril

Vídeo 1:07:57



CLIENTE	Deitado, joelho tombado para fora.
TERAPEUTA	Ajoelhado ao lado.
REGIÃO	Quadril (rotação externa e abdução).
FERRAMENTA	Mãos.
OBJETIVO	Aumentar a amplitude do quadril em pessoas rígidas e com dor lombar.
CUIDADOS	Pare quando sentir que o movimento travou.

PASSO A PASSO

1. Deixe o joelho do cliente cair para fora.
2. Com uma mão de apoio, desenhe meios círculos em três pontos: para baixo em direção ao chão e para cima em direção à axila, como um compasso.
3. Para mais amplitude, prenda a outra perna do cliente com o seu pé e use as duas mãos.

DECÚBITO DORSAL

09 Torção e alongamento transversal

Vídeo 1:10:13



CLIENTE	Deitado, perna cruzada para o outro lado.
TERAPEUTA	Em afundo, pés encaixados junto ao quadril do cliente.
REGIÃO	Lombar, glúteo e fibras transversas das costas.
FERRAMENTA	Mãos na coxa e o peso do corpo.
OBJETIVO	Torção da coluna e alongamento profundo da região lateral do quadril.
CUIDADOS	Vá e volte devagar. Não faça em quem tem cirurgia recente na coluna.

PASSO A PASSO

1. Leve o joelho do cliente para o outro lado em direção ao chão, com o seu pé travando para ele não sair do lugar.
2. Encaixe um pé no espaço entre as pernas dele e o outro colado à coxa.
3. Apoie a perna do cliente sobre a sua crista ilíaca e faça um afundo para a frente.
4. Para aumentar, empurre a coxa para baixo com as mãos.

DECÚBITO DORSAL

10 Balanço diagnóstico

Vídeo 1:34:11



CLIENTE	Deitado, sem travesseiro.
TERAPEUTA	Ajoelhado aos pés, tornozelos do cliente sobre a sua coxa.
REGIÃO	Corpo inteiro.
FERRAMENTA	Mãos.
OBJETIVO	Ver onde o corpo está preso: o balanço deve chegar até a cabeça, como uma onda.
CUIDADOS	Se o tórax ou o pescoço se movem em bloco, ali há tensão a trabalhar.

PASSO A PASSO

1. Segure por baixo dos calcanhares.
2. Balance o corpo do cliente em ritmo suave.
3. Observe se o movimento chega ao nariz. Onde ele para é onde está o bloqueio.

DECÚBITO DORSAL

11 Tração da perna em pé

Vídeo 1:37:14



CLIENTE	Deitado.
TERAPEUTA	Em pé, a perna do cliente encaixada atrás do seu glúteo.
REGIÃO	Lombar e quadril.
FERRAMENTA	Peso do corpo.
OBJETIVO	Tracionar a lombar e soltar o quadril.
CUIDADOS	Mantenha a tração o tempo todo, sem soltar.

PASSO A PASSO

1. Gire o pé do cliente levemente para dentro.
2. Encaixe a perna dele atrás do seu quadril e segure na altura do seu ombro.
3. Jogue o corpo para trás: a tração chega até a cabeça do cliente.
4. Sem perder a tração, desloque-se de um lado para o outro.

DECÚBITO DORSAL

12 Alongamento posterior em 4

Vídeo 1:39:19



CLIENTE	Deitado, perna apoiada no ombro do terapeuta.
TERAPEUTA	Em pé ou agachado, em postura de guerreiro.
REGIÃO	Posterior da coxa e lombar.
FERRAMENTA	Ombro, mãos e peso do corpo.
OBJETIVO	Alongar o posterior para soltar a lombar.
CUIDADOS	Mantenha a sua coluna alinhada e use o corpo como alavanca, não os braços.

PASSO A PASSO

1. Toque atrás do joelho do cliente com o seu joelho para ele dobrar sozinho.
2. Forme um "4" com a perna e leve-a até o seu ombro.
3. Com uma mão no pé e outra atrás da coxa, incline o corpo para a frente e alongue.
4. Variação: braço estendido na perna do cliente, em postura de guerreiro.

DECÚBITO DORSAL

13 Pés na crista: joelhos ao chão

Vídeo 1:41:50



CLIENTE	Deitado, as duas pernas dobradas.
TERAPEUTA	Em pé, os pés do cliente apoiados na sua crista ilíaca.
REGIÃO	Quadril e lombar.
FERRAMENTA	Peso do corpo, mãos nas canelas.
OBJETIVO	Soltar o quadril e a lombar com o peso do corpo.
CUIDADOS	Base aberta e postura alinhada.

PASSO A PASSO

1. Apoie os dois pés do cliente na sua crista, com as pontas para fora.
2. Coloque as mãos próximas às canelas.
3. Leve os joelhos do cliente em direção ao chão, usando só o peso do corpo, e solte o ar.

DECÚBITO DORSAL

14 Tração do trapézio

Vídeo 1:44:11



CLIENTE	Deitado, braços ao lado do corpo.
TERAPEUTA	Sentado sobre os pés do cliente, com uma almofada entre vocês.
REGIÃO	Trapézio e cervical.
FERRAMENTA	Mãos e o peso do corpo.
OBJETIVO	Tracionar e relaxar o pescoço e os ombros.
CUIDADOS	Peça para o cliente soltar a cabeça. A almofada deixa o contato mais confortável.

PASSO A PASSO

1. Coloque uma almofada sobre os pés do cliente e sente-se próximo aos joelhos.
2. Segure o trapézio com as duas mãos.
3. Empurre o seu quadril para trás para tracionar e saia devagar.
4. Pode alternar de um lado para o outro.

Decúbito ventral

Cliente deitado de barriga para baixo. As costas são a região que mais concentra queixas.

- **15** Pressão palmar ao lado da coluna
- **16** Para baixo e para fora
- **17** Alongamento do ombro com o braço na coxa
- **18** Pisada na planta dos pés
- **19** Panturrilha com o antebraço
- **20** Posterior da coxa com a canela
- **21** Alongamento do psoas
- **22** Apoio sob a crista ilíaca
- **23** Extensão com os punhos

DECÚBITO VENTRAL

15 Pressão palmar ao lado da coluna

Vídeo 2:21:40



CLIENTE	Deitado de barriga para baixo.
TERAPEUTA	Em tripé, ao lado do cliente.
REGIÃO	Musculatura paravertebral, da lombar para cima.
FERRAMENTA	Palmas.
OBJETIVO	Soltar a musculatura das costas.
CUIDADOS	Nunca pressione sobre a coluna. Pode repetir várias vezes.

PASSO A PASSO

1. Comece próximo da lombar, com as palmas espalmadas ao lado da coluna.
2. Pressione para baixo e solte, subindo pelas costas.
3. Repita a pressão também na lateral do tronco.
4. Variação: com os joelhos sobre o glúteo do cliente, mesma pressão ao lado da coluna.

DECÚBITO VENTRAL

16 Para baixo e para fora

Vídeo 2:22:31



CLIENTE	Deitado de barriga para baixo.
TERAPEUTA	Ao lado do cliente.
REGIÃO	Musculatura paravertebral.
FERRAMENTA	As duas mãos lado a lado.
OBJETIVO	Afastar e soltar a musculatura presa ao lado da coluna.
CUIDADOS	Acompanhe a respiração do cliente.

PASSO A PASSO

1. Coloque uma mão ao lado da outra, junto à coluna.
2. Pressione para baixo e deslize para fora.
3. Suba e desça pelas costas e repita do outro lado.

DECÚBITO VENTRAL

17 Alongamento do ombro com o braço na coxa

Vídeo 2:23:53



CLIENTE	Deitado, cabeça virada para o lado oposto.
TERAPEUTA	Ajoelhado em tripé, o braço do cliente sobre a sua coxa.
REGIÃO	Ombro e trapézio.
FERRAMENTA	Mãos e o peso do corpo.
OBJETIVO	Abrir e alongar o ombro.
CUIDADOS	Não puxe: o alongamento vem de sentar nos calcanhares.

PASSO A PASSO

1. Traga a mão do cliente sobre a sua coxa, palma para baixo.
2. Segure por baixo do ombro, como um gancho.
3. Sente-se nos calcanhares: o corpo faz o alongamento.
4. Variação com a palma virada para cima, alongando o bíceps.

DECÚBITO VENTRAL

18 Pisada na planta dos pés

Vídeo 2:26:31



CLIENTE	Deitado de barriga para baixo.
TERAPEUTA	Em pé, de costas para o cliente.
REGIÃO	Planta dos pés.
FERRAMENTA	Meio do pé; a lateral do pé para mais intensidade.
OBJETIVO	Soltar a fáscia plantar e estimular os pontos de reflexologia.
CUIDADOS	Cuidado com os dedos. Pode doer um pouco: vá com calma.

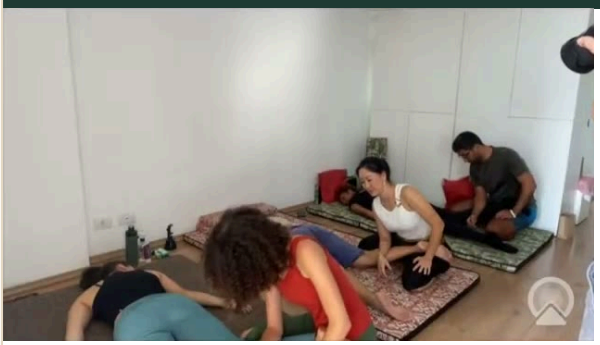
PASSO A PASSO

1. Pise com o meio do seu pé no meio do pé do cliente.
2. Trabalhe os dois pés juntos ou um de cada vez, como em um afundo.
3. Para mais intensidade, use a lateral do pé. Pode ficar de cinco a dez minutos.

DECÚBITO VENTRAL

19 Panturrilha com o antebraço

Vídeo 2:29:54



CLIENTE	Deitado, joelho dobrado, pé apoiado na coxa do terapeuta.
TERAPEUTA	Sentado a 45 graus, como um samurai.
REGIÃO	Panturrilha.
FERRAMENTA	Antebraço.
OBJETIVO	Liberar a panturrilha sem precisar de dor.
CUIDADOS	Liberação não precisa machucar. Onde houver tensão, apenas sustente.

PASSO A PASSO

1. Apoie o pé do cliente perto da sua virilha.
2. Leve o corpo à frente e gire o antebraço sobre a panturrilha, de palma para baixo a palma para cima.
3. Onde sentir um nódulo, pare e sustente de 10 a 20 segundos.
4. Termine com batidinhas leves, de mão fechada.

DECÚBITO VENTRAL

20 Posterior da coxa com a canela

Vídeo 2:31:21



CLIENTE	Deitado, joelho aberto para fora.
TERAPEUTA	Ajoelhado, a canela encaixada na coxa do cliente.
REGIÃO	Posterior e lateral da coxa.
FERRAMENTA	Canela; a mão no chão dá estabilidade.
OBJETIVO	Pressão ampla e confortável na coxa.
CUIDADOS	Variação tradicional: com o pé, em pé, para quem tem pé grande.

PASSO A PASSO

1. Abra o joelho do cliente para fora e encaixe a sua canela.
2. Apoie a mão no chão e trave o corpo.
3. Solte o ar e pressione; suba ponto a ponto pela coxa.

DECÚBITO VENTRAL

21 Alongamento do psoas

Vídeo 2:33:04



CLIENTE	Deitado, cabeça virada para o lado.
TERAPEUTA	Em pé do lado oposto, segurando o pé e o calcanhar.
REGIÃO	Psoas e flexores do quadril.
FERRAMENTA	Mãos; a ponta do pé apenas apoia a lombar.
OBJETIVO	Alongar o psoas, encurtado em quem passa muito tempo sentado, e aliviar a lombar.
CUIDADOS	O pé na lombar não faz força nenhuma: o peso fica todo na sua outra perna.

PASSO A PASSO

1. Segure a ponta do pé e o calcanhar do cliente.
2. Dê alguns passos para trás, a cerca de 45 graus.
3. Apoie apenas a ponta do outro pé na lombar.
4. Puxe a perna para trás com suavidade e volte.

DECÚBITO VENTRAL

22 Apoio sob a crista ilíaca

Vídeo 2:34:44



CLIENTE	Deitado, quadril apoiado sobre a coxa do terapeuta.
TERAPEUTA	Sentado, com a coxa sob a crista ilíaca do cliente.
REGIÃO	Lombar e quadril.
FERRAMENTA	Coxa e o peso do próprio cliente.
OBJETIVO	Aliviar a crise lombar sem força.
CUIDADOS	Em crise de dor não se usa força: aqui o alívio vem do apoio e do balanço.

PASSO A PASSO

1. Dobre a perna do cliente, segurando o joelho.
2. Escorregue a sua coxa por baixo, até ficar sob a crista ilíaca dele.
3. Estique a perna do cliente e deixe-o relaxar. Pode fazer um balanço leve.
4. Pode ficar uns cinco minutos. Para sair, dobre a perna e deslize devagar.

DECÚBITO VENTRAL

23 Extensão com os punhos

Vídeo 2:36:58



CLIENTE	Deitado, segurando os punhos do terapeuta.
TERAPEUTA	Ajoelhado, os joelhos na dobra do glúteo do cliente.
REGIÃO	Coluna, peito e abdômen.
FERRAMENTA	Peso do corpo.
OBJETIVO	Estender a coluna e abrir o peito.
CUIDADOS	Conduza a mão do cliente até o seu punho: não peça só com palavras.

PASSO A PASSO

1. Encaixe os joelhos na dobra do glúteo.
2. Deslize a mão pelo braço do cliente até o punho; os dois seguram o punho um do outro.
3. Na expiração, sente-se nos calcanhares, elevando o tronco dele. O cliente olha para cima.
4. Volte devagar e repita. Para cliente grande: em pé, com agachamento.

Decúbito lateral

Cliente deitado de lado. Ótima posição para a lombar profunda, o pescoço e a escápula.

- **24** Quadrado lombar: três pontos
- **25** Tração do ombro
- **26** Base do crânio
- **27** Gancho na escápula
- **28** Alongamento lateral com o braço
- **29** Abertura do peito com os pés
- **30** Torção lateral com agachamento

DECÚBITO LATERAL

24 Quadrado lombar: três pontos

Vídeo 2:53:13



CLIENTE	Deitado de lado.
TERAPEUTA	Sentado de frente para o ponto, bem colado ao cliente.
REGIÃO	Quadrado lombar, a parte mais profunda da lombar.
FERRAMENTA	Polegares sobrepostos.
OBJETIVO	Aliviar a lombar, inclusive em crise.
CUIDADOS	Dói em todo mundo. Pergunte a dor de 0 a 10: trabalhe até 7, ou 3 a 4 em pessoas sensíveis. Antebraço só para quem tem prática.

PASSO A PASSO

1. Localize a coluna, a última costela e a crista ilíaca: entre elas há um espaço vazio.
2. Ponto 1: um dedo ao lado da coluna. Ponto 2: logo acima. Ponto 3: no espaço entre a costela e a crista.
3. Pontos 1 e 2: com os polegares sobrepostos, pressione em direção ao umbigo por 10 segundos.
4. Ponto 3: pressione em direção ao chão. Entre contando 1, 2, 3 e saia do mesmo jeito.

DECÚBITO LATERAL

25 Tração do ombro

Vídeo 2:57:32



CLIENTE	Deitado de lado, braço solto.
TERAPEUTA	Sentado, encostado perto da escápula do cliente.
REGIÃO	Ombro.
FERRAMENTA	Mãos.
OBJETIVO	Soltar o ombro.
CUIDADOS	Movimento leve.

PASSO A PASSO

1. Segure o ombro do cliente.
2. Puxe em sua direção e volte, algumas vezes.

DECÚBITO LATERAL

26 Base do crânio

Vídeo 2:58:01



CLIENTE	Deitado de lado.
TERAPEUTA	Sentado atrás, perto da cabeça.
REGIÃO	Base do crânio e cervical.
FERRAMENTA	Base da mão; dedos com suavidade.
OBJETIVO	Aliviar a tensão do pescoço e a dor de cabeça.
CUIDADOS	Região sensível: faça suave. Termine com movimentos circulares, sem força.

PASSO A PASSO

1. Palpe a base do crânio, junto à raiz do cabelo.
2. Empurre em direção ao centro da cabeça enquanto puxa o ombro para baixo.
3. Trabalhe dois ou três pontos.
4. Finalize com círculos leves para tirar a sensação de dor.

DECÚBITO LATERAL

27 Gancho na escápula

Vídeo 2:59:56



CLIENTE	Deitado de lado, braço solto.
TERAPEUTA	Sentado atrás.
REGIÃO	Borda da escápula.
FERRAMENTA	Dedos em gancho.
OBJETIVO	Soltar a escápula.
CUIDADOS	O braço do cliente precisa estar bem relaxado.

PASSO A PASSO

1. Encontre a escápula e encaixe os dedos por baixo da borda.
2. Puxe em sua direção e solte. Repita.

DECÚBITO LATERAL

28 Alongamento lateral com o braço

Vídeo 3:01:00



CLIENTE	Deitado de lado, braço sobre a coxa do terapeuta.
TERAPEUTA	Em tripé, atrás do cliente.
REGIÃO	Lateral do tronco e ombro.
FERRAMENTA	Mãos; uma apoia na crista ilíaca.
OBJETIVO	Abrir espaço e alongar toda a lateral do corpo.
CUIDADOS	A mão na crista é só apoio.

PASSO A PASSO

1. Traga o braço do cliente sobre a sua coxa, palma para baixo, e segure o punho.
2. Apoie a outra mão na crista ilíaca.
3. Alongue o braço para longe do quadril, ajustando o seu corpo ao dele.

DECÚBITO LATERAL

29 Abertura do peito com os pés

Vídeo 3:01:55



CLIENTE	Deitado de lado, braço levado para trás.
TERAPEUTA	Sentado, um pé sob a escápula e o outro ao lado da coluna.
REGIÃO	Peito e ombro.
FERRAMENTA	Pés (apoio) e mãos (tração).
OBJETIVO	Abrir o peito.
CUIDADOS	Movimento controlado, com a respiração.

PASSO A PASSO

1. Leve o braço do cliente para trás, palma para cima, e segure a mão.
2. Apoie um pé sob a escápula e o outro ao lado da coluna.
3. Na expiração, puxe a mão em sua direção e volte.

DECÚBITO LATERAL

30 Torção lateral com agachamento

Vídeo 3:02:52



CLIENTE	Deitado de lado, joelho de cima dobrado formando um triângulo.
TERAPEUTA	Em pé, um pé atrás do joelho do cliente e o outro ao lado da lombar.
REGIÃO	Coluna e lateral do tronco.
FERRAMENTA	Mãos nos punhos e o peso do corpo.
OBJETIVO	Alongamento transversal da coluna.
CUIDADOS	Cirurgia recente na coluna: não faça torções. Cirurgia antiga: menos força e mais controle.

PASSO A PASSO

1. Posicione os pés: um atrás do joelho, o outro ao lado da lombar.
2. Segure o punho do cliente e peça que ele segure o seu.
3. Faça um agachamento leve na expiração e volte. Pode estalar, ou não.

Sentado

Cliente sentado. Fechamento da sessão, com foco no trapézio e na abertura do peito.

- **31** Pressão palmar no trapézio
- **32** Antebraço no trapézio com alongamento
- **33** Trapézio com tração do braço
- **34** Abertura do peito com a mão na orelha
- **35** Gato e vaca assistido
- **36** Inclinação lateral
- **37** Torção sentada
- **38** Remando o barco
- **39** Percussões de encerramento

SENTADO

31 Pressão palmar no trapézio

Vídeo 3:17:10



CLIENTE	Sentado.
TERAPEUTA	Atrás do cliente.
REGIÃO	Trapézio.
FERRAMENTA	Palmas.
OBJETIVO	Aquecer e soltar o trapézio.
CUIDADOS	Trabalhe a parte muscular, mole. Evite o osso do ombro.

PASSO A PASSO

1. Palpe e encontre a parte macia do trapézio.
2. Pressione para baixo, perto da cervical e depois mais para fora.

SENTADO

32 Antebraço no trapézio com alongamento

Vídeo 3:17:51



CLIENTE	Sentado, cabeça inclinada para o lado.
TERAPEUTA	Em tripé, ao lado do cliente.
REGIÃO	Trapézio, perto do pescoço.
FERRAMENTA	Antebraço; a mão segura a cabeça.
OBJETIVO	Soltar o trapézio enquanto alonga a lateral do pescoço.
CUIDADOS	Sem força excessiva. Para cliente grande, faça em pé.

PASSO A PASSO

1. Apoie o antebraço no trapézio, perto do pescoço.
2. Pressione para baixo e deslize, alongando com a mão na cabeça.
3. Repita do outro lado.

SENTADO

33 Trapézio com tração do braço

Vídeo 3:18:59



CLIENTE	Sentado, a mão sobre o joelho do terapeuta.
TERAPEUTA	Em tripé, à frente e ao lado.
REGIÃO	Trapézio e braço.
FERRAMENTA	Antebraço e mão.
OBJETIVO	Liberar o trapézio enquanto o braço se alonga.
CUIDADOS	Mantenha o braço do cliente esticado.

PASSO A PASSO

1. Segure os dedos do cliente.
2. Com o antebraço, empurre o trapézio para baixo enquanto puxa o braço.
3. Empurre e puxe em ritmo.

SENTADO

34 Abertura do peito com a mão na orelha

Vídeo 3:19:26



CLIENTE	Sentado, mão atrás da orelha.
TERAPEUTA	Atrás, o joelho dá apoio às costas.
REGIÃO	Peito e ombro.
FERRAMENTA	Mãos no punho e no cotovelo.
OBJETIVO	Abrir o peito.
CUIDADOS	O joelho só impede que o cliente saia do lugar.

PASSO A PASSO

1. Leve a mão do cliente até a orelha.
2. Segure o punho e o cotovelo.
3. Inspire e, ao soltar o ar, estique o braço dele para trás.

SENTADO

35 Gato e vaca assistido

Vídeo 3:20:49



CLIENTE	Sentado, mãos no chão à frente.
TERAPEUTA	Atrás, as mãos nas costas.
REGIÃO	Coluna inteira.
FERRAMENTA	Mãos.
OBJETIVO	Mobilizar a coluna com a respiração.
CUIDADOS	As mãos do cliente ficam paradas no chão, não deslizam.

PASSO A PASSO

1. Na inspiração, o cliente olha para cima e abre o peito.
2. Na expiração, arredonda as costas enquanto você empurra suavemente.
3. Repita algumas vezes.

SENTADO

36 Inclinação lateral

Vídeo 3:21:25



CLIENTE	Sentado, dedos cruzados atrás da cabeça.
TERAPEUTA	Atrás, o joelho apoiado sobre a coxa do cliente.
REGIÃO	Lateral do tronco.
FERRAMENTA	Braços e apoio do joelho.
OBJETIVO	Alongamento lateral.
CUIDADOS	Ao atender, apoie a mão nas costas do cliente para evitar contato do peito.

PASSO A PASSO

1. O cliente cruza os dedos atrás da nuca.
2. Apoie o joelho na coxa dele, sem força.
3. Na inspiração, leve o corpo para o lado. Volte e repita do outro lado.

SENTADO

37 Torção sentada

Vídeo 3:23:56



CLIENTE	Sentado, uma perna cruzada.
TERAPEUTA	Atrás.
REGIÃO	Coluna.
FERRAMENTA	Uma mão no braço e outra na escápula.
OBJETIVO	Torção da coluna.
CUIDADOS	Se estiver difícil, faça com a perna aberta.

PASSO A PASSO

1. Passe a mão por dentro e segure o braço do lado oposto.
2. A outra mão apoia na escápula.
3. Gire o tronco na expiração e volte. Repita do outro lado.

SENTADO

38 Remando o barco

Vídeo 3:24:43



CLIENTE	Sentado, braços à frente, palmas para cima.
TERAPEUTA	Sentado atrás, pés nas costas do cliente.
REGIÃO	Costas e peito.
FERRAMENTA	Pés (apoio) e mãos (punhos).
OBJETIVO	Alongar a coluna e abrir o peito.
CUIDADOS	Força de no máximo 20%: só estique os joelhos, não puxe com os braços.

PASSO A PASSO

1. Segurem o punho um do outro.
2. Apoie os pés sob as escápulas, ao lado da coluna.
3. Apenas estique os joelhos. O cliente olha para cima.
4. Mude os pés de lugar ao longo das costas.

SENTADO

39 Percussões de encerramento

Vídeo 3:26:18



CLIENTE	Sentado.
TERAPEUTA	Atrás.
REGIÃO	Costas e trapézio.
FERRAMENTA	Mãos em concha e mãos unidas.
OBJETIVO	Finalizar e despertar o corpo.
CUIDADOS	Use a base da mão firme e os dedos soltos para fazer o som.

PASSO A PASSO

1. Concha: mãos em concha, com um espaço no meio. Percuta de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo e de baixo para cima.
2. Mãos unidas, como em prece: percuta com os dedos soltos, na mesma ordem.
3. Termine com a intenção e o agradecimento.

Complemento do livro

Variações da sequência sentada descritas no capítulo "Manual de Thai Massagem Passo a Passo" do livro de referência, que complementam a aula.

- **40** Torção com apoio do antebraço
- **41** Thai Toilet
- **42** Círculos palmares e giros de antebraço

COMPLEMENTO DO LIVRO

40 Torção com apoio do antebraço

Livro, fig. 128

FOTO DA MANOBRA

CLIENTE	Sentado, uma mão sobre o ombro oposto.
TERAPEUTA	Atrás do cliente, uma perna apoiando as costas dele.
REGIÃO	Coluna torácica e lombar, cinturas escapular e pélvica.
FERRAMENTA	Mãos sustentando o antebraço do cliente.
OBJETIVO	Torção da coluna com dissociação das cinturas e ajuste postural.
CUIDADOS	Hérnia de disco, osteoporose e dor lombar aguda: amplitude reduzida ou não aplicar.

PASSO A PASSO

1. O cliente cruza o braço à frente do peito.
2. O terapeuta sustenta o antebraço dele com as duas mãos.
3. Na expiração, conduz o tronco em rotação, mantendo o quadril estável.
4. Sustente alguns segundos, volte devagar e repita para o outro lado.

COMPLEMENTO DO LIVRO

41 Thai Toilet

Livro, fig. 130

FOTO DA MANOBRA

CLIENTE	Sentado, braços elevados ou para trás.
TERAPEUTA	Atrás do cliente, joelhos apoiados nas costas dele.
REGIÃO	Quadrado lombar ou região torácica.
FERRAMENTA	Joelhos (pressão) e mãos (tração dos braços).
OBJETIVO	Favorecer a extensão da coluna e abrir o peito.
CUIDADOS	Manobra intensa. Contraindicada em hérnia de disco, osteoporose, gestação e lombalgia aguda.

PASSO A PASSO

1. Posicione os joelhos em dois pontos sobre o quadrado lombar (ou dois pontos torácicos).
2. Segure os braços do cliente.
3. Na expiração, puxe os braços para trás enquanto os joelhos sustentam a coluna.
4. Solte devagar e repita, respeitando o limite do cliente.

COMPLEMENTO DO LIVRO

42 Círculos palmares e giros de antebraço

Livro, fig. 131

FOTO DA MANOBRA

CLIENTE	Sentado, tronco levemente inclinado à frente.
TERAPEUTA	Atrás do cliente, de joelhos ou sentado.
REGIÃO	Costas, musculatura paravertebral e escápulas.
FERRAMENTA	Palmas e antebraços.
OBJETIVO	Relaxar e integrar o trabalho feito nas costas.
CUIDADOS	Pressão confortável, sem apoiar sobre a coluna.

PASSO A PASSO

1. Faça círculos amplos com as palmas por toda a superfície das costas.
2. Passe para giros com o antebraço sobre a musculatura, dos dois lados da coluna.
3. Mantenha um ritmo lento e contínuo, acompanhando a respiração do cliente.

ANEXO · FICHA DE ANAMNESE

Ficha de anamnese

Reproduza esta ficha para cada cliente. Guarde com sigilo.

Nome _____ Data _____

Idade _____ Profissão _____ Telefone _____

Queixa principal _____

Desde quando / o que piora / o que melhora _____

Medicamentos em uso _____

Cirurgias e lesões anteriores _____

Marque se possui

- ☐ Hipertensão
- ☐ Problemas cardíacos
- ☐ Trombose / varizes
- ☐ Diabetes
- ☐ Osteoporose
- ☐ Hérnia de disco
- ☐ Prótese articular
- ☐ Gestação
- ☐ Câncer (atual ou tratado)
- ☐ Uso de anticoagulante
- ☐ Lesão recente
- ☐ Labirintite / tontura

Avaliação

Postura e observações _____

Testes de amplitude (antes) _____ Testes de amplitude (depois) _____

Objetivo da sessão _____

Manobras aplicadas _____

Orientações de autocuidado _____

Assinatura do cliente (declaro que as informações são verdadeiras) _____

ANEXO · GLOSSÁRIO

Glossário

Nuad นวด
Massagear, tocar com intenção terapêutica.

Nuad Boran นวดแผนโบราณ
"Massagem antiga", o nome da forma tradicional.

Sen เส้น
Linha, canal por onde circula a energia vital.

Sen Sip
As dez linhas Sen principais.

Interagente
Termo usado no livro de referência para o cliente, que participa da sessão.

Nuad Raksa
Nuad Thai terapêutico, de uso clínico.

Rishis
"Videntes" em sânscrito; os sábios que, pela tradição, receberam o Ayurveda.

Onculi
Medida tradicional equivalente à largura de uma falange do dedo do próprio cliente.

Jantala Kala e Surya Kala
Nomes de Itha (lunar) e Pingkhala (solar) nas placas de Wat Pho.

Jantapusang e Rucham
Nomes de Lawusang e Ulangka em Wat Pho.

Chiwhasadom
Ponto ligado a Sumana, que governa a língua, a boca e os cinco sabores.

Chakala Wayo
O "vento ruim", que perturba o fluxo nas linhas.

Lom ลม
Vento, a energia vital que circula pelas Sen.

Thatu
Elementos que compõem o corpo: terra, água, vento e fogo.

Wai Khru ไหว้ครู
Saudação e prece de respeito aos mestres, feita antes da sessão.

Shivago Komarpaj
Médico do Buda, considerado o pai da medicina tailandesa.

Wat วัด
Templo budista. O Wat Pho, em Bangkok, é o berço da Thai Massage.

Ruesi Dat Ton ฤๅษีดัดตน
Exercícios de autoalongamento dos eremitas, usados no autocuidado.

Luk Pra Kob ลูกประคบ
Compressa de ervas aquecida, usada junto ou após a massagem.

Metta
Bondade amorosa, atitude central do terapeuta.

Brahmaviharas
As quatro atitudes do coração: metta, karuna, mudita e upekkha.

Decúbito dorsal / lateral / ventral
Cliente deitado de barriga para cima, de lado ou de barriga para baixo.

ANEXO · REFERÊNCIAS

Referências

Obras consultadas na elaboração deste material. O conteúdo foi reescrito e adaptado para fins didáticos.

- *Nuad Thai: Thai Massagem*. Livro de referência do curso. Capítulos 2 (O budismo em direção à Tailândia e o médico de Buda), 12 (Os dez canais por onde flui lom pran) e 14 (As tábuas de Wat Pho e pontos de acupressão). Ilustrações de André Utimura.
- TANGTRONGCHIT, P. *Manual de Thai Massagem e Pontos de Wat Pho*. 2004.
- Wat Pho Thai Traditional Medical and Massage School. *Tamra Ya: The Philosophy Stones of Wat Pho*. 2016.
- HOSKIN, J. *An Illustrated History of Thailand*. John Beaufoy Publishing, 2016.
- UNESCO. *Nuad Thai, traditional Thai massage*. Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, 2019.



Obrigada por estar aqui

Que cada toque seu leve presença, respeito e cuidado. A técnica você aprende com a prática. A presença você cultiva todos os dias.

INSTITUTO YUMI KATAOKA

@yumikataoka · institutoyumikataoka.com.br

WhatsApp (11) 98560-4140

Material de apoio didático. Não substitui avaliação médica. Proibida a reprodução sem autorização.